ONEMA-POP-025 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-025 — Acolhimento e Estabilização Inicial em Crise Aguda de Ansiedade/Pânico

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de acolhimento e estabilização inicial em crise aguda de ansiedade/pânico em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Crise de ansiedade ou pânico com paciente estável após exclusão inicial de sinais de emergência; não pressupor etiologia psiquiátrica. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: equipamento de sinais vitais na visita e contato de emergência; paciente: lista de medicamentos e pessoa de apoio.

5. Avaliação e preparo

Início, gatilhos, dor torácica, dispneia, síncope, uso de substâncias, glicemia quando indicada, risco de autoagressão e histórico.

6. Execução técnica numerada

1. Apresentar-se, garantir ambiente calmo e verificar se há ameaça imediata à segurança.

2. Avaliar nível de consciência, respiração, dor torácica e sinais vitais quando presencial.

3. Se sinais compatíveis com emergência cardiopulmonar, neurológica ou metabólica, acionar SAMU 192.

4. Na ausência de sinais graves, oferecer escuta breve, frases claras e reduzir estímulos.

5. Orientar respiração confortável e lenta sem impor hiperventilação ou respiração em saco de papel.

6. Investigar uso de estimulantes, suspensão de medicamentos e risco de autoagressão.

7. Pactuar apoio de pessoa de confiança e avaliação clínica/saúde mental conforme necessidade.

8. Reavaliar sintomas e registrar desfecho e orientações.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dor torácica persistente, dessaturação, síncope, déficit focal, intoxicação ou risco suicida: encaminhamento emergencial.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar retorno imediato se novos sinais físicos; não banalizar primeira crise.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 NICE CG113 — Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults — https://www.nice.org.uk/guidance/cg113

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.